

気分障害

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
精神科・児童精神科
持田 圭仁

気分障害：目次

- ◆ 総論
 - ◆ 疾病分類と診断基準
 - ◆ 疫学
 - ◆ 成因
 - ◆ 治療
 - ◆ 経過と予後
-

- ◆ 本人、家族との信頼関係の構築
 - ◆ 初期評価
 - ◆ 初診時の症状
 - ◆ 症状発現までの経緯、寛解・増悪因子
 - ◆ 希死念慮の有無
 - ◆ 過去の気分(特に躁病)エピソード
 - ◆ 過去の自殺企図の既往
 - ◆ 過去の精神科既往・治療歴
 - ◆ 家族歴
 - ◆ 治療の場を外来とするか、入院とするか
 - ◆ 本人は病識に乏しいことあり⇒医療保護入院なども念頭に置く
-

うつ病の治療 原則(1)

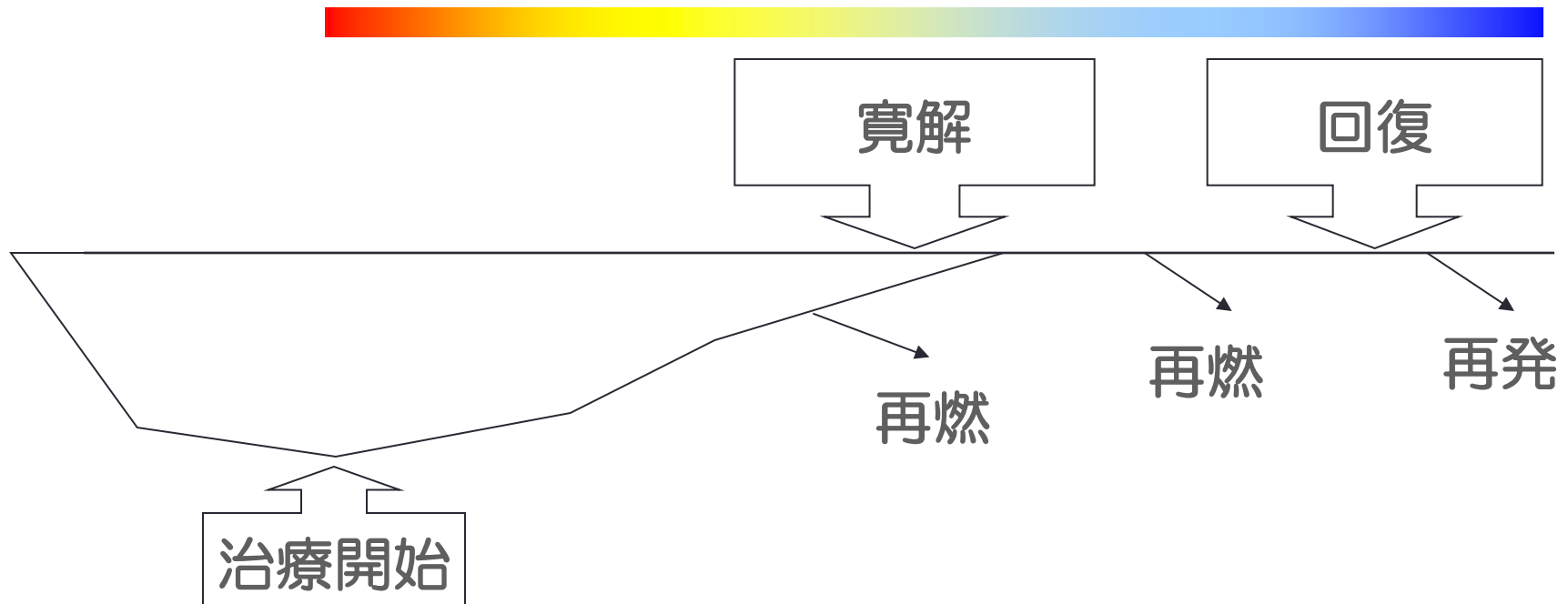
重要

◆ うつ病の治療は 急性期治療、継続治療、維持治療の3つの段階に分けられる

急性期：安全確保・症状軽減

継続期：社会復帰

継続期：再発予防



- ◆ すべての治療は、うつ病の性質や経過、治療手段に関する心理教育を併せて、臨床的配慮のもとに行う
- ◆ 薬物療法だけでなく、支持的な対応を心がけること、ストレス内容への配慮が治療的であるし、また治療有効性を高めるためにも重要
 - ◆ 休養を促す
 - ◆ 重大な決断はしない
- ◆ 副作用や、実質的な改善が表われるまで 2-3週間を要することを患者に伝えること

- ◆ 中等度から重症：本格的な精神療法が併用されるか否かに拘わらず、薬物療法によって治療するのが適切
- ◆ 軽症：薬物療法は有効であるが、臨床的に遭遇する抑うつ状態のもっとも軽症の者に対しては有効でない(有害事象が優る)

Fournier JC, et al. JAMA. 2010

- ◆ 反応性か内因性か、あるいは誘因があるか否かという病因論的区別は、うつ病の診断の決定と治療の要否の判断にとって、もはや重要な区別であるとはみなされない

国家試験過去問

- ◆ 52歳男性 倦怠感と気分不快を主訴に来院。部長に昇進してから症状出現。仕事に集中できず、続ける自信がない。責任の重さのあまり、将来も悲観的。特に朝気分がすぐれない。
 - ◆ 正しいのはどれか？
 - ◆ a.幻覚の有無が診断上重要である
 - ◆ b.脳の画像診断を直ちに行う必要がある
 - ◆ c.抗不安薬が第一選択薬である
 - ◆ d.自殺の危険性に対して配慮する
 - ◆ e.「がんばれば元気になる」と励ます
-

国家試験過去問

- ◆ うつ病女性が辞職希望。産業医として助言？
 - ◆ a.一人旅行
 - ◆ b.職場配置換え
 - ◆ c.症状寛解まで決断延期
 - ◆ d.人事課への辞表提出
 - ◆ e.入院
 - ◆ 昇進後うつ病、上司と来院。上司への指示？
 - ◆ a.勤務はそのまま続ける
 - ◆ b.職場での地位を元に戻す
 - ◆ c.職場の配置換えをする
 - ◆ d.休養させる
 - ◆ e.転職をすすめる
-

国家試験過去問

- ◆ 62歳女性 再発乳がん「もう死にたい」。対応は？
 - ◆ a.患者を一人にしておく
 - ◆ b.患者の気持ちや考えを詳しく聞く
 - ◆ c.がんばるよう励ます
 - ◆ d.一旦抗がん治療を中止する
 - ◆ e.安楽死の求めに応じる
 - ◆ 50歳男性、食欲不振、倦怠感を精査するも異常なし。「もう死にたい」不適切な対応は？
 - ◆ a.患者の背景を尋ねる
 - ◆ b.前医に検査と治療内容を尋ねる
 - ◆ c.仕事を休むように勧める
 - ◆ d.元気を出すように励ます
 - ◆ e.薬物療法を開始する
-

国家試験過去問

- ◆ 3か月前に就職した23歳の男性。睡眠障害と全身倦怠感を訴え、産業医に相談。日中に強い眠気。2週間前から食欲が低下し、やる気が起きない、ミスも増えている。
 - ◆ 相談を受けた産業医の対応として最も適切なものはどれか。
 - ◆ a.特に何もしない
 - ◆ b.直ちに休職させる
 - ◆ c.医療機関の受診を勧める
 - ◆ d.もう少し様子を見るよう勧める
 - ◆ e.他の同期入職者も頑張っているからと励ます
-

- ◆再燃/再発の防止：薬物が有用であるという非常に強力な証拠が存在
- ◆初発患者においてはうつ病挿話の発症が特定しにくいため、十分量の抗うつ剤を、症状寛解の後も継続治療として 6から9ヵ月 (大うつ病の平均持続期間)使用する
- ◆3回以上のうつ病相のあった患者は、長期の維持治療を考慮
 - ◆急性期治療において有効であったものと同じタイプを同じ投与量

国家試験過去問

- ◆ 45歳男性。会社員。昇進半年後から入眠困難。仕事でケアレスミス。その後、食欲不振が出現。産業医に勧められ受診。妻子と暮らす。抑うつ状態で希死念慮を認め、うつ病と診断され入院。抗うつ薬などによる治療後、退院可能となった。
- ◆ 主治医の今後の対応として最も適切なのはどれか。
 - ◆ a.退院前に抗うつ薬を減量する。
 - ◆ b.職場での配置転換を会社に指示する
 - ◆ c.退院直後の職場復帰を本人へ指導する
 - ◆ d.家族に対して本人への接し方を助言する
 - ◆ e.発症前のペースで業務が行えるよう励ます

- ◆ 原則的に単剤で開始
 - ◆ 患者・家族に十分な説明を行う
 - ◆ 効果発現までに2-4週程度要すること
 - ◆ 有害事象が先行する可能性
 - ◆ 少量から開始し、副作用に注意しながら漸増
 - ◆ 必要なら、初期のみ抗不安薬を併用
-

- ◆ どれか特定の抗うつ剤が他の抗うつ剤よりも明らかに有効性が高い、あるいは効果発現が早いという証拠は少ない
- ◆ 薬物は症状を軽減することを証明された分量を処方しなくてはならない
 - ◆ 三環系抗うつ薬ならば75 mg程度
 - ◆ SSRIなら標準投与量の下限が初期の目標。標準投与量の上限では作用・副作用バランスが悪くなる

うつ病の薬物療法（3）抗うつ薬

重要

種別	一般名	商品名	特徴
三環系	アミトリプチリン	トリプタノール	抗うつ効果強いが、 副作用も強い (抗コリン作用) 鎮痛補助効果
	クロミプラミン	アナフラニール	
	ノルトリプチリン	ノリトレン	
	イミプラミン	トフラニール	
四環系	ミアンセリン	テトラミド	抗うつ効果弱い 催眠作用
SARI	トラゾドン	レスリン	
SSRI	フルボキサミン パロキセチン セルトラリン エスシタロプラム	デプロメール パキシル ジェイゾロフト レクサプロ	効果と忍容性のバ ランス良好 不安障害にも適応 薬物相互作用有 嘔気など
SNRI	ミルナシبران デュロキセチン	トレドミン サインバルタ	薬物相互作用少 鎮痛補助効果
NaSSa	ミルタザピン	レメロン	強い抗うつ効果 眠気、食欲増進

余談

◆精神科の面白い(?)webサイト

<http://psychodoc.eek.jp/abare/>



◆精神科薬広告図像集

→精神科の雑誌に掲載された薬の広告
薬の名前が覚えやすくなるかも

◆私家版・精神医学用語辞典→電気ショック療法

→電気けいれん療法の昔と今について

◆黄色い救急車研究所→精神病院と都市伝説

→読み応えがあります

国家試験過去問

- ◆ 45歳男性 3ヶ月前からの食欲不振、不眠、意欲低下、集中力低下で来院。適切な治療薬はどれか？
 - ◆ a. フェノバルビタール
 - ◆ b. アミトリプチリン
 - ◆ c. シメチジン
 - ◆ d. ジアゼパム
 - ◆ e. 総合消化酵素薬
-

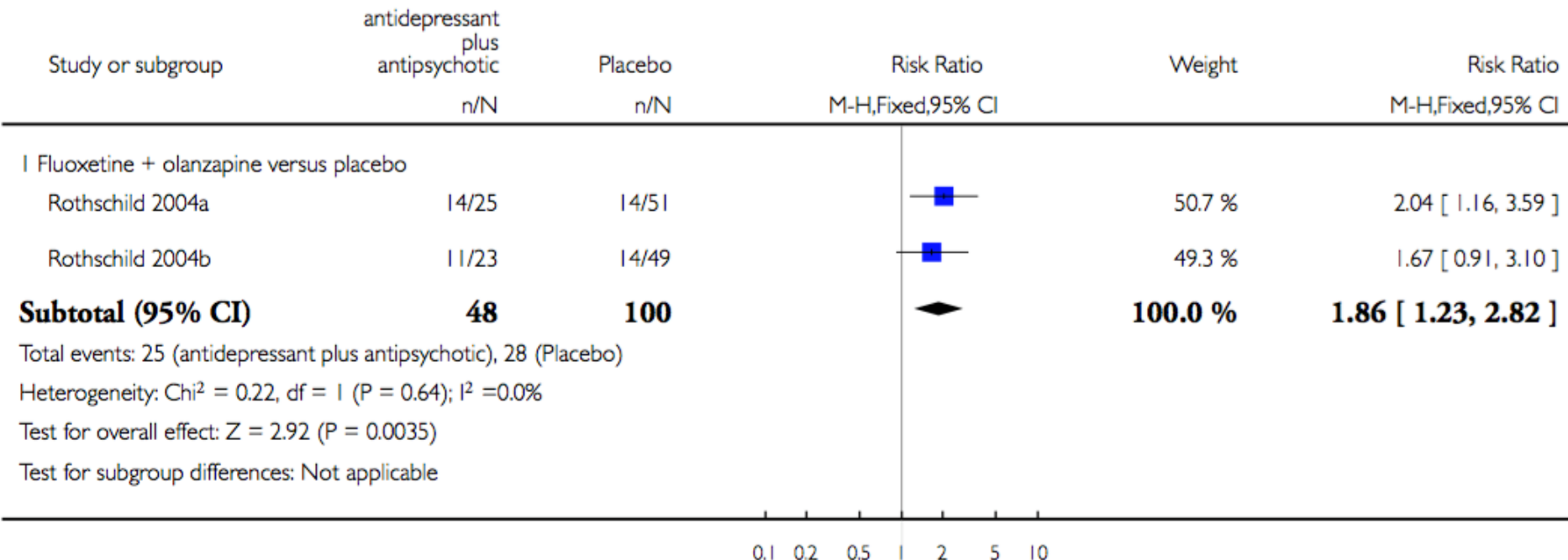
◆抗うつ薬の有害事象

特性	副作用
コリン阻害性	口渇、便秘、排尿障害・尿閉、眠気、せん妄
セロトニン作動性	嘔気・嘔吐、食欲低下、離脱症状(退薬症状)
ノルアドレナリン阻害性	起立性低血圧

精神病性うつ病の薬物療法

- ◆ 抗うつ薬のみ、抗精神病薬のみでは有効とのエビデンスなし
- ◆ 抗うつ薬＋抗精神病薬はそれぞれ単剤やプラセボより有効

(Wijkstra J, et al. Cochrane Database Syst Rev, 2013)



プラセボ

非三環系＋抗精神病薬

- ◆約30%の患者は、1種類目の抗うつ薬に反応しない
 - ◆約10-20%の患者は、少なくとも2種類の抗うつ薬による適切な(十分な量、十分な期間)治療に反応しない
 - ◆電気けいれん療法(ECT)
 - ◆リチウム増強
 - ◆2種類の抗うつ薬を組み合わせる
 - ◆甲状腺ホルモンを加える
 - ◆抗精神病薬を加える
-

- ◆ 軽症うつ病に推奨される(薬物と比較して、効果・副作用との観点から)
 - ◆ 中等～重症のうつ病には薬物療法の補助療法として使用される
 - ◆ 精神療法は、薬物療法と比較してエビデンスの集積が不足している
 - ◆ 精神療法同士の効果を比較した研究は乏しい
-

認知行動療法

- ◆ 認知、行動、感情、身体は相互に密接に関連
⇒ 不快な感情(抑うつ、不安、怒りなど)や身体症状を軽減するために、認知および行動の側面から働きかける精神療法
 - ◆ うつ病の場合・・・
 - ◆ 認知の歪みに気が付く
 - ◆ 別の物事の見方、考え方、意味づけ方を学ぶ
 - ◆ 新しく学んだ考え方を元に行動する
-

対人関係療法

- ◆抑うつは社会的、または対人関係的な脈絡から生じる
 - ◆過去ではなく現在の対人関係に注目する
 - ◆心的な内面を洞察するのではなく、対人関係そのものにフォーカスを当てる
 - ◆ロールプレイングなど
 - ◆例) 自己主張訓練：自分の感じていることや考えていることなどの言いたい事を、自分も相手の立場や気持ちを大切にしながら伝える
-

力動的的精神療法 (精神分析)

- ◆ 洞察精神療法の一種
 - ◆ 患者に生じている問題を、患者の無意識や幼少時の体験などに起因させる治療方法
 - ◆ 過去に一世を風靡したために一般的にもよく知られているが、他の精神療法に比較しても、その有用性を示すエビデンスに乏しい
-

問題解決療法

Nezu, Nezu, & Perri, 1989;
Nezu, & D' Zurilla, 1989;
D' Zurilla, & Nezu, 1989

問題解決療法

Problem Solving Therapy

Step 1

Problem orientation
問題のとらえ方

Step 2

Problem definition
解決可能な問題の同定

Step 3

Generation of alternatives
解決策の生成

Step 4

Decision making
解決策の選択

Step 5

Solution
implementation &
validation
解決策の実行と評価

問題の捉え方を学ぶ

- ・ 今、自身に起こっていることをどのように捉えているかを評価する
- ・ 問題に対する肯定的な態度

解決策を考える

目標を達成するための解決策

1. 数のルール

良し悪しは考えず、自由にできるだけ多く解決策を考える

2. 判断を遅らせるルール

解決策の効果判断は後回し

3. 作戦-戦術のルール

作戦を立て、そのための具体的な戦術を考える

解決策の実行と評価

- ・ 実行した解決策の結果の評価
- ・ トラブルシューティング
- ・ コントロール感を高める

問題の明確化・目標設定

- ・ 現在気になっていること、問題は何か明らかにする
- ・ その問題の性質を明らかにする
- ・ 解決できそうな問題であるかどうか判断する
- ・ 解決のための”現実的”な目標設定を行う

より良い解決策の選択

- ・ 目標を達成するために、それぞれの解決策について、Pros（メリット）とCons（デメリット）を考える
- ・ メリットの大きい効果的な解決策を選択する

問題解決療法の例

28歳男性

問題解決療法

Problem Solving Therapy

問題提起

最近、遅刻が多い

代替可能な解決策の産出

1. 仕事を早く終わらせる
2. 同僚に仕事を手伝ってもらう
3. 上司に仕事を減らしてもらう
4. 心療内科を受診する

実施と検証

- ・ 思い切って心療内科を受診した
- ・ 「軽いうつ病」と言われて薬をもらった
- ・ すぐに眠れて朝も起きれるようになった
- ・ しばらくして移動となり、仕事の負荷が減った
- ・ 業務に穴をあけず、会社にも知られずに、乗り切れた

Step 1

Problem orientation
問題のとらえ方

Step 2

Problem definition
解決可能な問題の同定

Step 3

Generation of alternatives
解決策の生成

Step 4

Decision making
解決策の選択

Step 5

Solution
implementation &
validation
解決策の実行と評価

明確化・定式化

- ・ 早く帰宅ができない
- ・ 夜、眠れない
- ・ 朝、起きれない

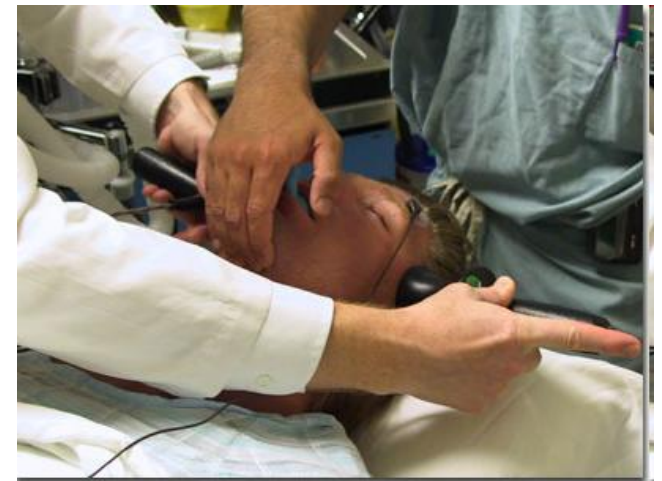
意思決定

1. 可能ならそれが一番
/ 実際には終わらない
2. 自分の仕事は楽になる
/ 同僚も忙しいので頼めない
3. 頼めば仕事は減らしてもらえる
/ 上司からの評価が下がる
4. 睡眠は確実に取れそう
/ 受診には抵抗がある

→仕事は終わらないし、職場の援助も得がたい→心療内科を受診

ECT

- ◆大うつ病、双極性障害の双方への有用性が確立している
- ◆手術室で施行。副作用に認知機能障害あり
- ◆スティグマのために、難治性うつ病の患者のみが対象となることが多い
- ◆精神病症状を伴う気分障害も良い適応とされる



Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

- ◆ 時間変化する磁場により、脳内に渦電流を誘導し、神経細胞を電氣的に刺激する
- ◆ うつ病治療では前頭葉を標的とする
- ◆ 刺激に際して疼痛は伴わない



TMSの有用性

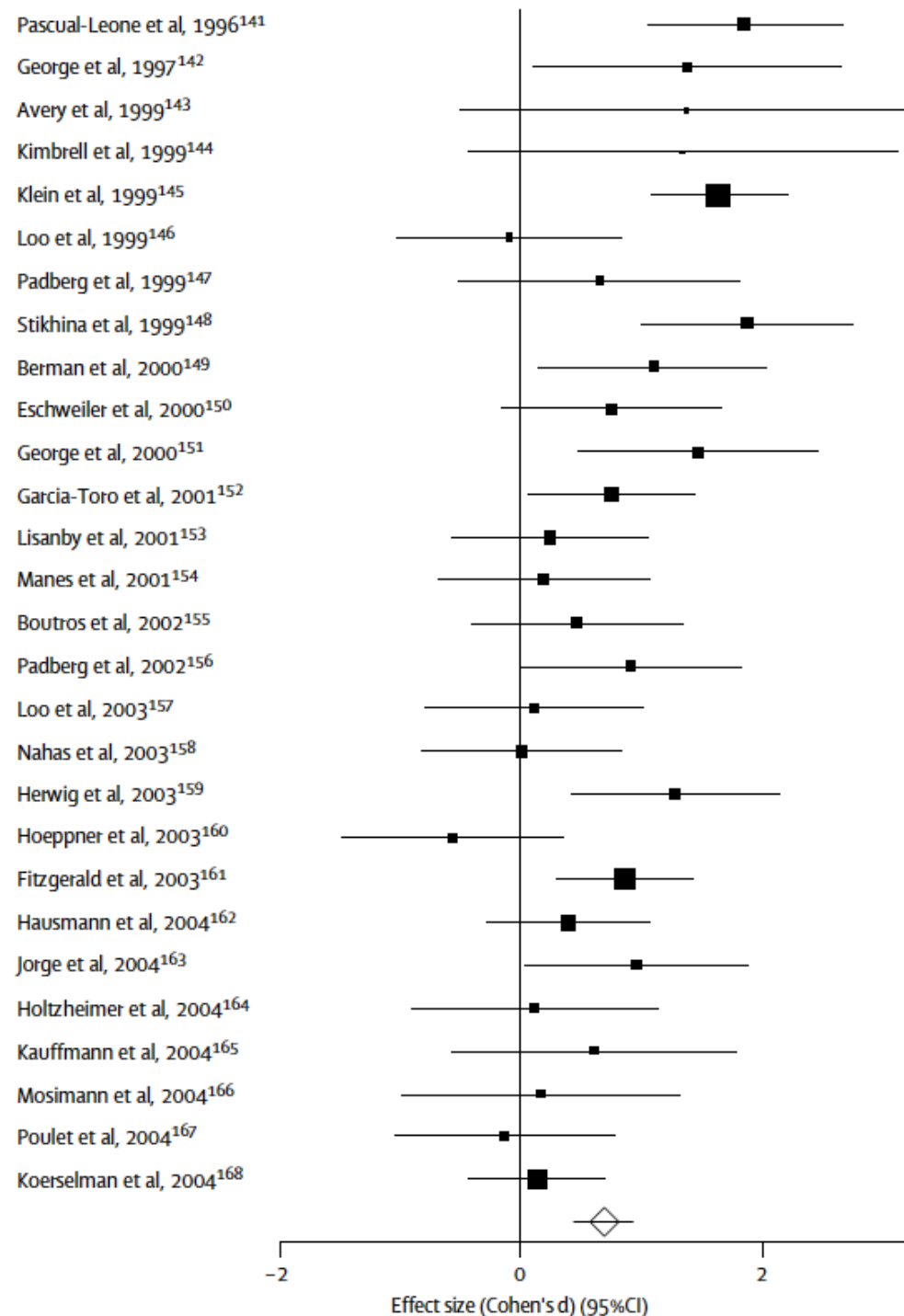
◆ Meta-analysisでは有用との結果

*Ebmeier KP, et al.
Lancet 2005*

◆ 2019年6月より保険 適応

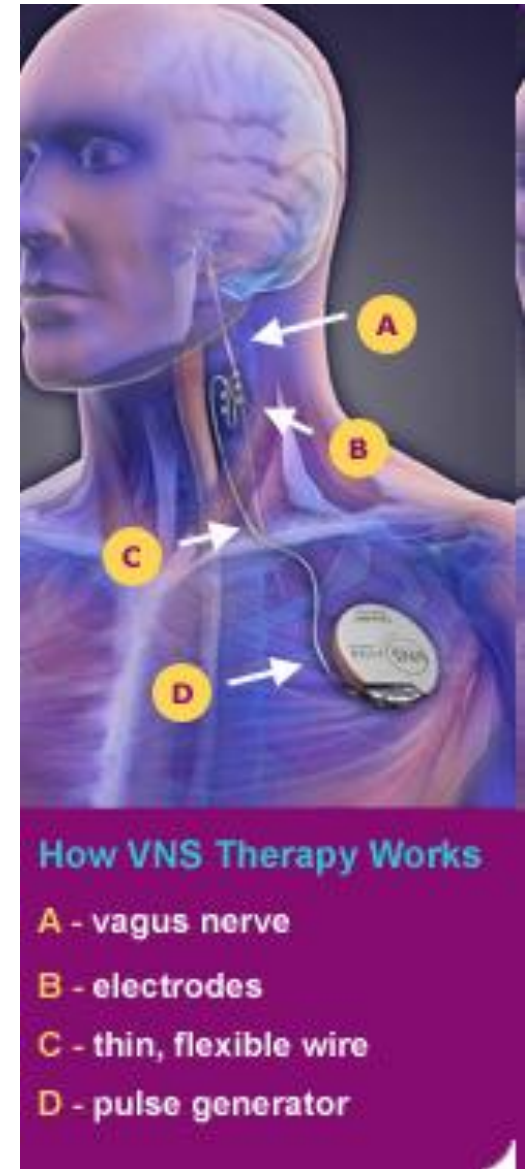
◆ 平日5日間の通院治療 を6週間行うのが一般 的（1回40分程度）

◆ 機器が高額



Vagus Nerve Stimulation (VNS)

- ◆ 電子的に迷走神経を刺激することでうつ病の改善を図る
- ◆ 侵襲性が高いため、難治性うつ病治療への適応が検討されている



国家試験過去問

◆60歳女性 2ヶ月前から臥床がちで「今年の所得税が払えない」「先祖供養が不十分でこうなった」不眠、食欲不振などもある。家族によると税務署から問い合わせがあったことを機に増悪。問い合わせに問題はなかった。

◆認める症状は？

◆a.認知症

◆b.せん妄

◆c.妄想

◆d.強迫

◆e.感情失禁

国家試験過去問(続き)

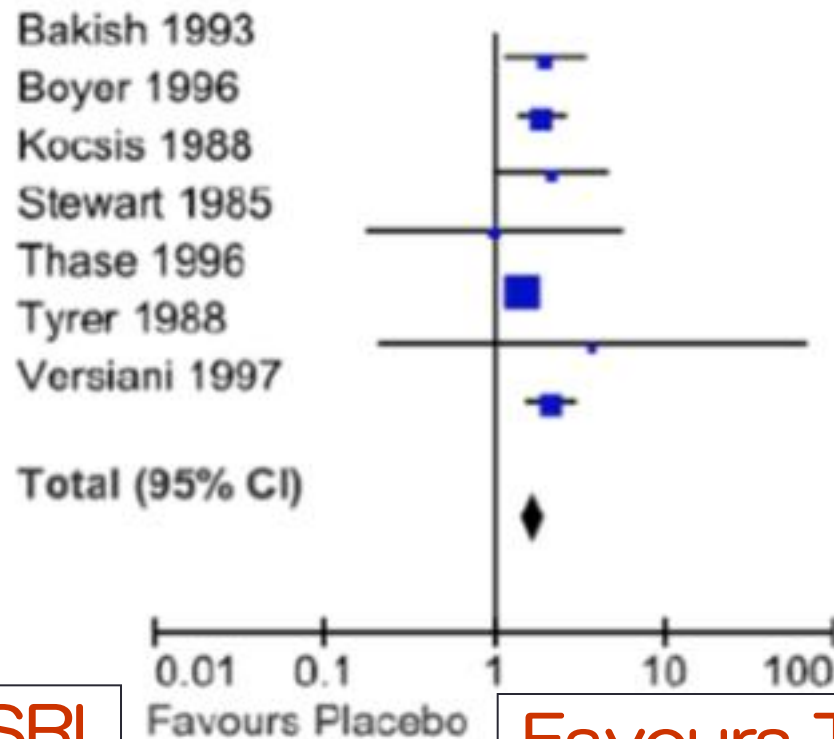
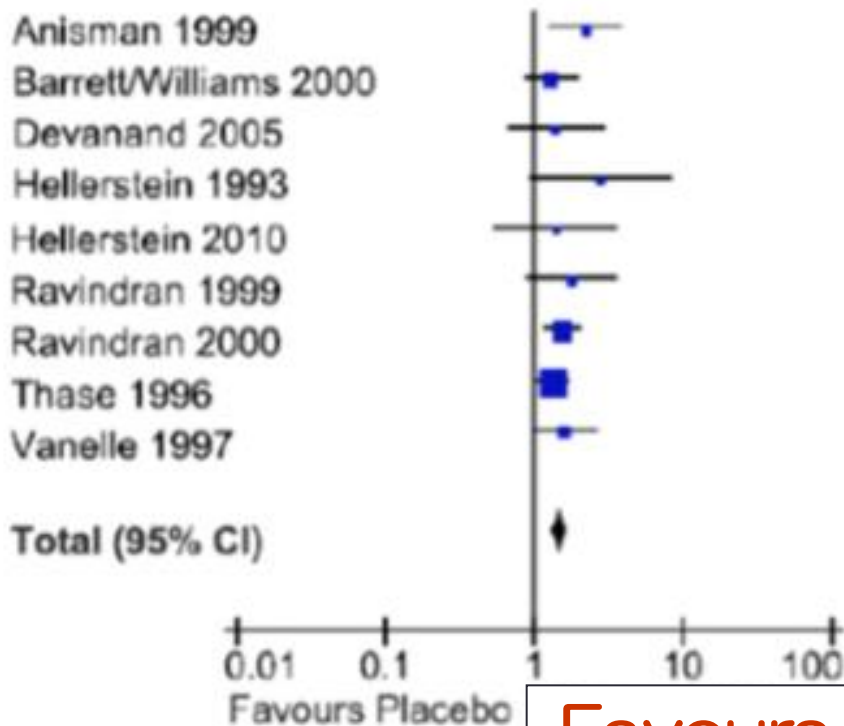
- ◆ 入院を勧めるも「入院費が払えない」と断固拒否。適切な処置は？
 - ◆ a. 本人の意思を尊重しそのまま帰宅
 - ◆ b. 1週間後の再受診を指示
 - ◆ c. 夫の同意を得て医療保護入院
 - ◆ d. 直ちに応急入院
 - ◆ e. 措置入院のための手続きをとる
 - ◆ この患者の治療として適切なものはどれか。
 - ◆ a. イミプラミン投与
 - ◆ b. ワーファリン投与
 - ◆ c. ジアゼパム投与
 - ◆ d. 持続的気道陽圧法
 - ◆ e. 電気けいれん療法
-

◆抗うつ薬の有用性が示されている

(*van Wolff, et al. K Affect Dis 2013*)

SSRI

三環系抗うつ薬



- ◆急性期治療vs維持治療と躁病相vsうつ病相の2x2表で考える必要あり
- ◆どの時期においても気分安定剤が主剤となる
 - ◆リチウム (リーマス®)
 - ◆腎機能障害、甲状腺機能低下に注意
 - ◆カルバマゼピン(テグレトール®)
 - ◆薬物相互作用に注意
 - ◆バルプロ酸 (デパケン ®)
 - ◆安全という点からは使用しやすい
- ◆加えて、病相に応じた薬物
 - ◆躁病相：抗精神病薬、うつ病相：抗うつ薬？

気分安定薬の作用機序

- ◆ 詳細は不明であるが、神経保護作用があるのではないかと考えられている
 - ◆ リチウムによる神経細胞死抑制作用発見が契機
 - ◆ In vivoでも神経保護作用
 - ◆ リチウムで大脳灰白質体積増大
 - ◆ その後、神経保護作用は気分安定薬に共通していることが明らかになってきた
-

- ◆気分安定薬が第一選択
 - ◆特にリチウムにエビデンス集積あり
 - ◆効果発現までに時間が必要⇒抗不安薬や抗精神病薬を併用することも多い
 - ◆血中濃度を測定し、適量を使用する
- ◆最近、抗精神病薬のほうが気分安定薬よりも有効との報告もあり

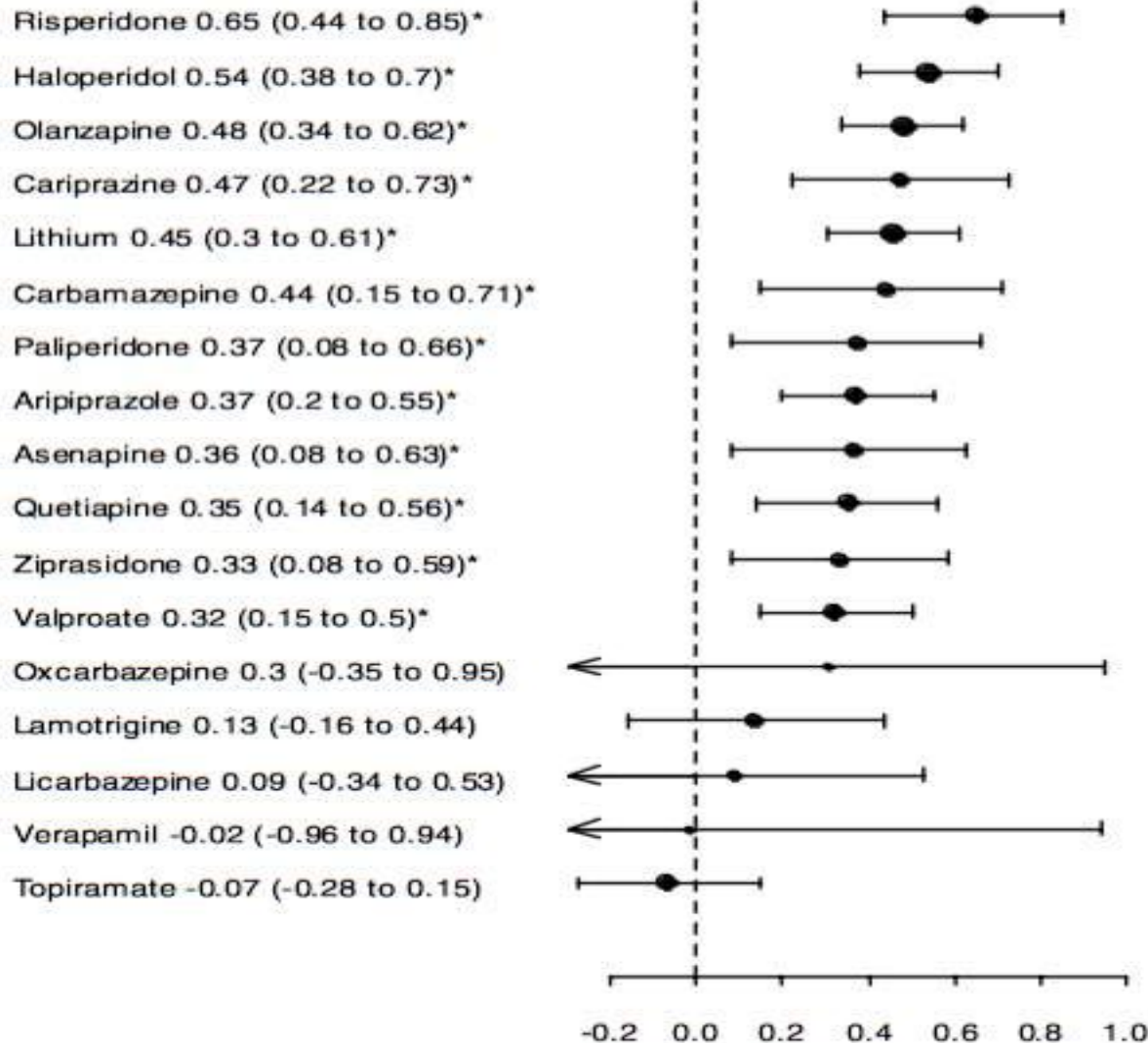
Cipriani et al. Lancet 2011

- ◆重症の場合、薬物療法への反応が乏しい場合はECTも検討
- ◆急速交代型(4回以上のエピソード／1年)ではバルプロ酸が推奨⇒否定的研究結果もあり

国家試験過去問

- ◆ 躁病の治療に用いられないものはどれか？
 - ◆ a. レボメプロマジン
 - ◆ b. ハロペリドール
 - ◆ c. カルバマゼピン
 - ◆ d. アミトリプチリン
 - ◆ e. リチウム
-

双極性障害 躁病：最近の知見



有効性：抗精神病薬、気分安定薬とも、躁病に有効

治療中断：オランザピン、リスペリドン、クエチアピン、バルプロ酸、アリピプラゾールは、プラセボより少なかった

実薬で良好⇒

双極性障害の治療：急性期 うつ病

重要

- ◆ 反応が乏しく、遷延しやすい。また自殺の危険性が高いため細心の注意が必要
- ◆ 気分安定薬、特にリチウムが第一選択
- ◆ 原則的に抗うつ薬単剤での治療はしない
 - ◆ 抗うつ薬のみの治療で、躁転する危険性あり
 - ◆ その危険性はTCAの方がSSRIより高く、双極Ⅱ型よりⅠ型で高い
- ◆ 気分安定薬への反応に乏しいなら、抗うつ薬併用と言われていたが、否定する研究報告

Nemeroff, et al. Am J Psychiatry. 2001
Sachs GS, et al. NEJM. 2007
- ◆ 薬物療法への反応が乏しいならECTも検討

双極性障害の治療：維持期

- ◆急性期エピソード後、6ヶ月以内は再燃・再発リスクが高い
- ◆寛解に達した患者の半数が2年以内に再発
- ◆3回以上の躁病エピソードがあるなら、生涯にわたって維持治療を行う

Perlis et al. Am J Psychiatry 2006

- ◆維持治療には気分安定薬が不可欠
 - ◆その中でも、リチウム、バルプロ酸、ラモトリジン、一部の非定型抗精神病薬が有用
 - ◆急性期治療で寛解に至ることができた薬物はそのまま併用する
 - ◆維持ECT
-

双極性障害の治療：精神療法

- ◆ 双極性障害の治療は薬物療法が中心ではあるが、精神療法の併用も有用
 - ◆ その目的は・・・
 - ◆ 疾患への理解を高める
 - ◆ 症状のモニタリングを行う
 - ◆ 薬物療法へのアドヒアランスを高める
-

双極性障害治療 リチウムvs抗うつ薬 **重要**

	リチウム	抗うつ薬
うつ病急性期治療	？(抗うつ薬増強効果はある)	有効
うつ病の再発予防	有効	有効
双極うつ病急性期治療	有効	？
躁・軽躁病急性期治療	有効	無効
躁・軽躁病の再発予防	有効	無効
他病相への移行予防	有効	無効
他病相への移行を惹起する可能性	なし	？

国家試験過去問

- ◆ 双極型うつ病と比較して、単極型うつ病の特徴として正しいのはどれか？
 - ◆ a.病前性格が循環気質
 - ◆ b.躁うつ病の遺伝負因がある
 - ◆ c.炭酸リチウム療法によく反応する
 - ◆ d.1回の病相の期間が短いものが多い
 - ◆ e.初回発症年齢が30歳以降のものが多い
-

気分障害：目次

- ◆ 総論
 - ◆ 疾病分類と診断基準
 - ◆ 疫学
 - ◆ 成因
 - ◆ 治療
 - ◆ 経過と予後
-

気分障害の予後

- ◆ エピソード予後は良いが、長期予後は反復性
 - ◆ 躁病エピソード：2ヶ月前後
 - ◆ 大うつ病エピソード：
 - ◆ 治療開始後3-6ヶ月で寛解に達する
 - ◆ 治療開始後2年以上続く例も10-20%存在
- ◆ 経過中、双極I型障害はII型に比べて躁／軽躁エピソードの出現が多く、II型はI型に比べて抑うつ傾向で経過しやすい

◆双極性障害：

- ◆自然経過では再発率90%以上、15%の患者は10以上のエピソード
- ◆維持治療が重要：しかし治療して寛解後、維持治療をしていても50%が2年以内に再発

◆うつ病：

- ◆再発率は5年目までで63%、再発までの期間は中央値で31ヶ月(NIMH CDS)
 - ◆1回目のエピソード：よくなってから6-9ヶ月は維持治療を
 - ◆3回以上：長期にわたる治療を考慮
-

- ◆わが国では年間約2万1000人が自殺(R5)
 - ◆90%以上がなんらかの精神科診断を有する
 - ◆双極性障害：企図率25-50%、既遂率10-15%、うつ病または混合エピソード時に多い
 - ◆うつ病：約50%の患者で希死念慮あり、うち企図するものは10-15%、既遂は5%前後
 - ◆気分障害患者の治療においては常に留意
 - ◆過去の自殺・自傷企図歴、精神疾患既往などが重要な予測因子
-

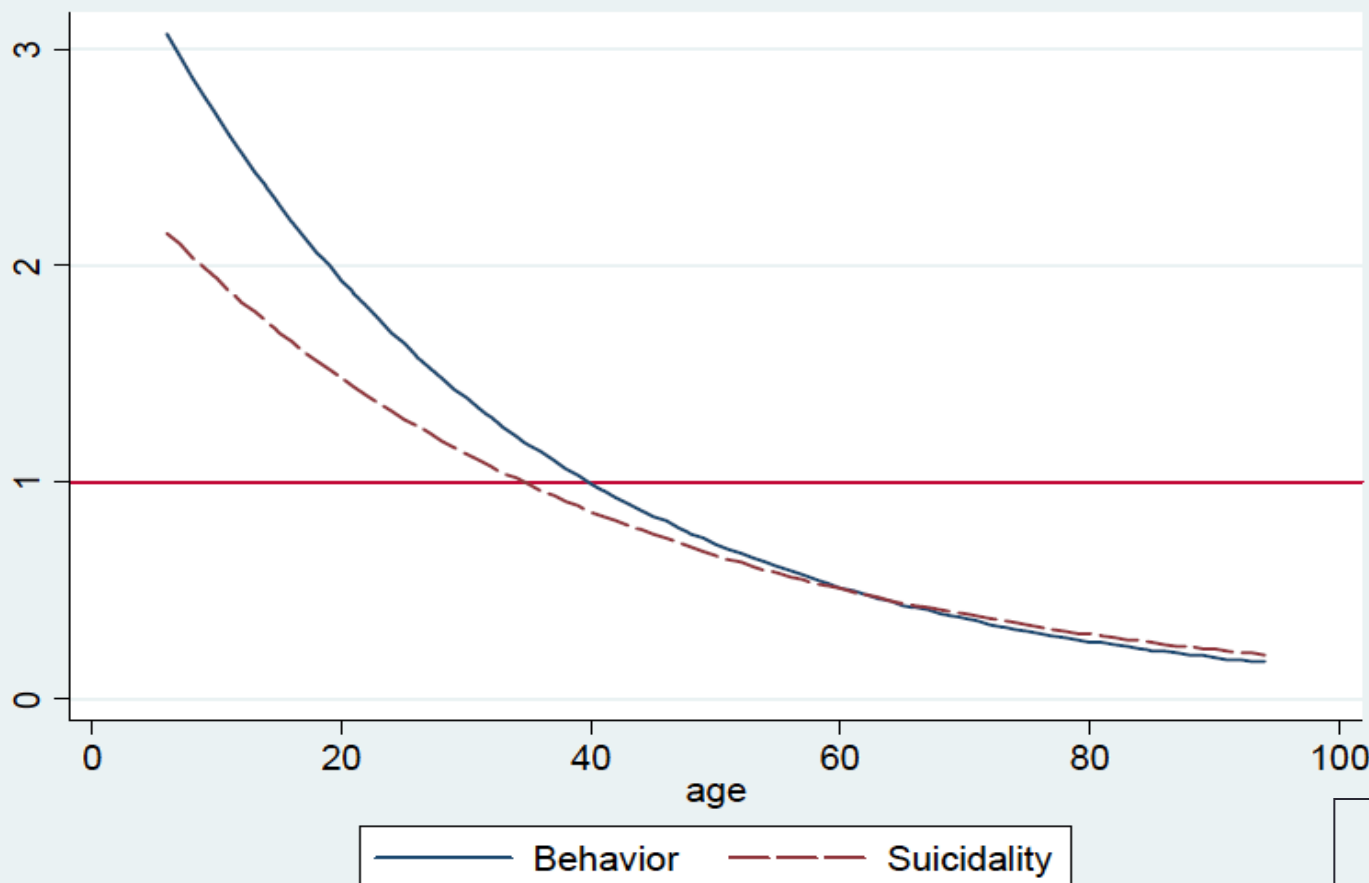
抗うつ薬と自殺

重要

Laughren, et al, FDA Briefing documents 2006

◆ 20代前半までの気分障害患者に抗うつ薬は処方しないほうが良い

リスク



年齢

国家試験過去問

◆48歳男性。3か月から不眠と食欲低下あり、仕事も手につかなくなった。勤務後に大量飲酒し、川に飛びこみ死のうとしたが道路側に転落し倒れていたところを発見された。「今は死にたいとは思わないが、また妻に心配をかけてしまった」と述べる。アルコール臭を認めるが意識は清明。後頭部に皮下血腫。神経学的所見異常なし。血液検査異常なし。頭部CT異常なし。対応として適切でないのはどれか。

- ◆a.精神科受診を勧める
- ◆b.自殺をしないよう約束させる
- ◆c.自殺企図のあったことを警察に通報する
- ◆d.大量のアルコール飲用について注意する
- ◆e.家族のサポートが必要であることを説明する

国家試験過去問

◆ 我が国の自殺の現状について正しいのはどれか。
2つ選べ。

- ◆ a.性別では女性が多い
 - ◆ b.手段では縊首が最も多い
 - ◆ c.動機では健康問題が最も多い
 - ◆ d.年間自殺者数は2万人以下になっている
 - ◆ e.人口10万人あたりの自殺者数は先進7か国で最も少ない
-

お疲れさまでした

